



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ايمان مصطفى محمد اسماعيل

المحافظة : الجيزة

الحي / المدينة : العمرانية

العنوان : ممممممممممممممممم

رقم البطاقة : 28208132102142 رقم التليفون : 01020019888

تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 13-08-1982 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: إيمان مصطفى محمد اسماعيل
National ID: 28208132102142



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

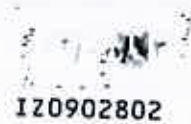
05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ايمان
مصطفى محمد اسماعيل
٥ ش خالد امين
العسرانيه - الجيزه



٢٨٢٠٨١٣٢١٠٢١٤٢

120902802



٢٠٢١/٠٧ ٢٨٢٠٨١٣٢١٠٢١٤٢
مهندسه مدنيه حره
انثى
مسلمة
متزوجة
كريم حمدي محمد احمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٧/١٤



HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهة الاصدار : فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

لهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للائتمان التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "قانون التأمين والمعاشات
والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة
2012 "الأطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين ان

سيد (د) يمان مصطفى محمد بطاقة رقم 28208132102142

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
بغير من الفئات غير المستفيدة بالتأمين الصحي
وشكرا

حريم فر 2021-9-21



إدارة مركز نظم المعلومات
يعتمد



مسلسل 50852

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار

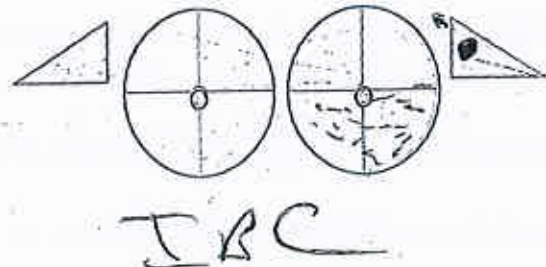


مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الصحة المصرية
مصر

MDT FORM

Name	اياد مكي
Age	(39)
MRN	
ID	٢٨٤٠٨١٤٢٠٩٤٤
Co morbidity	١٠٢٠١٩٨٨٨



Clinical Data

Bx: DC 2 II	SM:
IHC: 6/8 ER: 2/8 PR: 2/8 HerT: ++ CISH +ve KiTV:	Mets Workup: free
Left P. G. IBC CT _{4d} N ₂ M ₀ by PET	
COMMENT: - porta cth down - Echo & lab: OK	

MDT OUTCOME & PLAN

for - Moxdy chemo Taxol + Carb + Her aptin + perjeta then PRM - 2 lodes during chemo
--

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

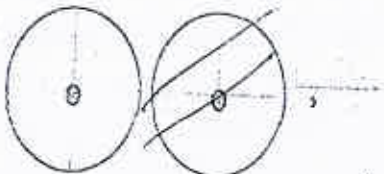
الكتب المقدسة
صَدَقَ
مَدَار

MDT FORM

17/3/2022

Name	Handwritten name	MRN	Handwritten MRN
Age	39	ID	Handwritten ID
Menopausal status	(P1)	Phone	Handwritten Phone
OCP		Marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx: IDC Cell				Clinical Data	
ER: 618	PR: 018	HER 2: +3	Ki67:	R	L
Sonomammography:					
Mets Workup:				CT, N, Mo CIBC	
Recommendations: received 5 cycles TCHP then LT MRM on 10/2/20 PCR 4PT0 4P No/12 started Femara					

MDT OUTCOME & PLAN

in view of Pathologic complete Respon
upto - YP No.

- To control Herceptin + pegylated up to 9 years.

Hemiaros, Zsladix

+ Part

MEDICAL ONCOLOGY		SURGERY		SIGNATURE		RADIOLOGY		PATHOLOGY	
Mullis		[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Imaging report

Mrs. Iman Moustafa Mohamed
Date : 02/09/2021



كايرو سكان
للشعة والتحاليل
CAIRO SCAN
Radiology & LABS

Prof. Hamdy Abdel Azeem
Code : R2562987

^{18}F FDG Whole Body PET/CT

Clinical Data:

- Female patient referred for whole body survey

Technique:

- Whole body ^{18}F -FDG images from skull to the mid thighs with the arms extending above the head were obtained approximately 1 hour after tracer injection.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.

Review of PET, CT and fused images revealed:

Status of left breast carcinoma no previous available CT films for comparison, the current study revealed:

I) BRAIN REVEALED:

- No hypermetabolic lesions detected.
- No evidence of intra-cerebral or extra-axial fresh blood density.
- Normal size and configuration of the ventricular system and subarachnoid basal cisterns as well as the cortical sulci on both sides.
- No definite cerebral areas of abnormal attenuation value.
- No shift of midline structures.
- Normal posterior fossa.
- Clear scanned para-nasal sinuses.

II) NECK REVEALED:

- No hypermetabolic lesions detected.
- Normal CT appearance of vaeulae, pyriform fossae and aryepiglottic folds.
- Patent nasopharyngeal and oro-pharyngeal air column.
- Bilateral deep cervical, submandibular and submental subcentemetric benign looking lymph nodes, likely non specific.
- Normal CT appearance of the parotid and submandibular salivary glands.
- Normal appearance of the thyroid gland.
- Normal appearance of the carotid sheath and its contents

Imaging report

Mrs. Iman Moustafa Mohamed
Date : 02/09/2021



كايرو سكان
للشعة والتحاليل
CAIRO SCAN
Radiology & LASS

Prof. Hamdy Abdel Azeem
Code : R2562987

III) THE CHEST REVEALED:

- Left breast dense breast shows metabolically active upper inner quadrant faint enhanced soft tissue mass measures 3.9x3.3 cm in diameter with few tiny satellite nodules seen surrounding associated with subtle thickening of the overlying skin showing SUVmax3.7.
- Metabolically active few left axillary as well as left subpectoral nodules with the largest seen on the left subpectoral region measures 15mm in diameter with SUVmax3.9
- Clear both lung fields with no evidence of pulmonary nodules, masses, infiltrations or bronchiectatic changes.
- Subtle bilateral pleural effusion.
- No pericardial sac collection.
- No grossly enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- Normal CT appearance of the heart, aorta and its great branches.

IV) THE ABDOMEN AND THE PELVIS REVEALED:

- No hypermetabolic lesions detected.
- Enlarged liver showing rounded borders and relatively homogenous low attenuation parenchymal texture denoting fatty infiltration. No evidence of definite enhanced focal hepatic masses or bile duct dilatation.
- Patent, homogeneously enhancing portal vein and its main branches.
- Status post abortion shows distended uterine cavity with subtle endometrial thickening and retained secretion.
- Right adnexal cyst of 22mm in diameter with no pathologic tracer uptake.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, kidneys, aorta, IVC and pelvic organs.
- No CT evidence of grossly enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No ascites.

IV) THE MUSCULOSKELETAL REVEALED

- No hypermetabolic lesions detected.
- L2 transverse sclerotic line with no pathologic tracer uptake?? fissure fracture

OPINION:

Imaging report

Mrs. Iman Moustafa Mohamed
Date : 02/09/2021



كايرو سكان
للأشعة والتحاليل
CAIRO SCAN
Radiology & LABS

Prof. Hamdy Abdel Azeem
Code : R2562987

- Metabolically active left breast lesions and left axillary & pectoral lymph nodes for correlation with histopathology
- No gross hypermetabolic lesions detected at the rest of the scanned body.

Best Regards,

Nuclear medicine consultant

Dr. Maha Abd Elkareem, MD

A. professor of Nuclear Medicine,
kasr al ainy, Cairo University

Radiology Consultant,

Dr. Nehal Abdel Shafy, MD

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on
radreport@cairoscan.com.eg

Imaging report



كايرو سكان
للاشعة والتحاليل
CAIRO SCAN
Radiology & Labs

Name : Mrs. Iman Moustafa Mohamed
Date : 30/08/2021

Prof. Hamdy Abdel Azim
Code : R2562987

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHIC EXAMINATION OF BOTH BREASTS:

CLINICAL SUMMARY : known case of left breast cancer.

IMPRESSION :

LEFT BREAST: (BIRADS 6)

Picture is those of multicentric neoplastic process with ipsilateral pathological lymph node.

RIGHT BREAST: (BIRADS 1)

- Normal study

DETAILED FINDINGS :

TECHNIQUE:

Craniocaudal & Mediolateral Oblique views
Contrast mammography/ high resolution ultrasound.

Both breasts showed heterogeneously dense parenchyma, (ACR c).

LEFT BREAST:

- Pre-contrast images:
- 1- Focal asymmetrical area with underlying parenchymal distortion and associated with suspicious microcalcifications are seen retroareolar and UIQ.
- 2- Suspicious microcalcifications are also seen extending to the UOQ.
- Post contrast images:
- 1- there is an area of non mass enhancement corresponding to the UIQ and retroareolar asymmetry located 1 cm from the nipple and 2.5 cm from the underlying muscle, measure 9 x 8 cm.

Imaging report



كايرو سكان
للتصوير والتشخيص
CAIRO SCAN
Radiology & LABS

Name : Mrs. Iman Moustafa Mohamed
Date : 30/08/2021

Prof. Hamdy Abdel Azim
Code : R2562987

- 2- Non mass enhancement is seen at the UOQ about 10 cm from the nipple corresponding to the mammographic evident UOQ microcalcifications, measure 3 x 3 cm in diameter.
- Para areolar skin thickening.
- Pathological axillary lymph node with cortical thickness 5 mm.

RIGHT BREAST:

- **Pre-contrast images:** No dominant mass lesion, spiculations or suspicious microcalcifications.
- **Post-contrast images:** no mass or non mass enhancement.
- No signs of malignancy detected.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary lymph nodes.

Thanks for your Reference,
Dr Hanaa Abo El Magd

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on
radreport@cairoscan.com.eg

Imaging report



كايرو سكان
للتصوير والتشخيص
CAIRO SCAN
Radiology & Ultrasound

Name : Mrs. Iman Moustafa Mohamed
Date : 30/08/2021

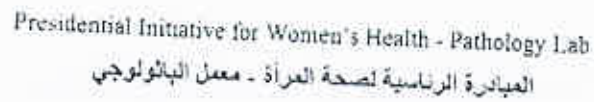
Prof. Hamdy Abdel Azim
Code : R2562987

Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS):

Your category is shaded below in gray.

The rest of the table is only for your information.

Category		
0	Needs further imaging study	
1	Negative (there is nothing to comment on)	
2	Benign Finding	
3	Probably Benign Finding	< 2% malignant risk short term follow up is recommended
4	Suspicious Abnormality	2- 95% malignant risk Biopsy should be considered
5	Highly suggestive of Malignancy	> 95% malignant risk Appropriate Action should be taken
6	Previous Biopsy	Proven Malignancy



Request No. : 138107
Request Date : 16/08/2021
Verification Date : 24/08/2021
Financial Category : وزارة الداخلية - نفقة الزوجة
Department : Out Patient

Patient Name	: الأستاذة / ايمان مصطفى محمد اسماعيل	Request No.	: 13005341
Patient No.	: 28208132102142	Request Date	: 17/02/2022
Path No.	: 454/2022	Verification Date	: 13/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer.

Nature of the specimen:

Left MRM.

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM specimen measured 24x21x4cm, with covering skin piece measured 19.5x14, nipple was retracted grossly.
- Tumor extent: An ill-defined rubbery greyish white & tan tumour bed site measured 5x3.5x3cm, with occasional dilated ducts oozing yellowish discharge.
- Distance from margins: 1cm away from deep margin, and just below the skin 0.2cm.
- Lymph nodes number and size: 12 lymph nodes up to 1.5x0.5cm.

Microscopic examination:

- Histological type: No remnants of tumour tissue.
- Lymph node involvement: All lymph nodes were free (0/12).
- Resection Margins: Free deep margin
- Free nipple and areola.
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response.
- Additional pathologic findings: Necrosis, hemorrhage, foamy histiocytes and chronic inflammatory reaction.

Diagnosis:

Left MRM:

- No remnants of tumour tissue.
- All lymph nodes were free (0/12).
- Free deep margin, nipple and areola.

Verified by :

abdelrahman ibrahim

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
العيادة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذة / ايمان مصطفى محمد اسماعيل
Patient No : 28208132102142
Path No. : 454/2022
Sex : Female
Age : 39 Y
Referring Doc :

Request No. : 13005341
Request Date : 17/02/2022
Verification Date : 13/03/2022
Financial Category : نفقة الدولة - وراثة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Pathologic complete response.
Stage ypT0, ypN0

Prof. Dr. Gamal Abd-El Aty
Dr. Abdurrahman Ibrahim

Verified by :
abdeirahman ibrahim

Printing Date : 16/03/2022 09:27:13

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

الهيئة العامة للغذاء والدواء - وزارة الصحة - جمهورية مصر العربية
H.E. Dr. Mohamed El-Dars - Ministry of Health - Egyptian Republic